

ORIGINAL

Factores psicosociales y laborales asociados al agotamiento laboral en profesionales sanitarios de un hospital de alta complejidad de Bogotá, Colombia



C.A. Estupiñán Ruiz^a y A.D. Gallego-Ardila^{b,*}

^a Facultad de Ciencias de la Salud, programa de Fisioterapia, Corporación Universitaria Iberoamericana, Bogotá, Colombia

^b Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Bogotá, Colombia

Recibido el 24 de junio de 2021; aceptado el 21 de diciembre de 2021

Disponible en Internet el 18 de febrero de 2022

PALABRAS CLAVE

Fisioterapia
especialidad;
Agotamiento
profesional;
Factores de riesgo

Resumen

Objetivo: Evaluar la asociación de los factores psicosociales y laborales frente a la presencia de agotamiento laboral en fisioterapeutas y terapeutas respiratorios de un hospital de alta complejidad de Bogotá, Colombia.

Materiales y métodos: Estudio transversal analítico. Se encuestaron a 31 fisioterapeutas y terapeutas respiratorios de un hospital de alta complejidad. La recolección de información se realizó a través de un cuestionario digital, incluyó variables psicosociales, demográficas y laborales. La prevalencia de *burnout* se evaluó mediante el *Maslach Burnout Inventory* para profesionales de la salud. Se realizaron análisis univariados y bivariados mediante SPSS versión 25.0.

Resultados: Se encontró que el 93,5% (n = 29) correspondió al sexo femenino, la media de edad fue de 36±8,7 años, con un tipo de vinculación laboral a término fijo del 96,8% (n = 30). El 38,7% (n = 12) de profesionales atiende más de 15 pacientes por turno. Frente a la presencia de *burnout*, el 38,7% (n = 12) presentan agotamiento laboral, ya sea por cansancio emocional, despersonalización o baja realización personal. Finalmente, un 64,5% (n = 20) y un 74,2% (n = 23) considera que su salud mental o física se ha deteriorado por las condiciones laborales dada la actual pandemia por SARS-CoV-2, respectivamente.

Conclusiones: Un porcentaje considerable de profesionales presenta agotamiento laboral. Se resaltan algunas condiciones psicosociales y laborales (insuficiente personal, jornada agotadora, falta colaboración, pérdida de información) asociadas a la presencia de *burnout*. Existe deterioro de la salud física y mental de los profesionales por la pandemia SARS-CoV-2.

© 2022 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: adgallego@fucsalud.edu.co (A.D. Gallego-Ardila).

KEYWORDS

Physiotherapy
specialty;
Professional burnout;
Risk factors

Psychosocial and working conditions associated with burnout among health professionals of a highly complex hospital in Bogotá, Colombia

Abstract

Objective: To evaluate the association of psychosocial and work factors in the presence of job exhaustion in physiotherapists and respiratory therapists of a highly complex hospital in Bogotá, Colombia.

Materials and methods: An analytical cross-sectional study. 31 physiotherapists and respiratory therapists from a high complexity hospital were surveyed. The data collection was carried out through a virtual questionnaire, it included psychosocial, demographic and labor variables; the prevalence of burnout was assessed using the Maslach Burnout Inventory for health professionals. Univariate and bivariate analyses were performed using SPSS version 25.0.

Results: It was found that 93.5% ($n = 29$) corresponded to female, the mean age was 36 ± 8.7 years old, with a type of fixed-term employment relationship of 96.8% ($n = 30$). Number of patients seen per shift of more than 15 patients in 38.7% ($n = 12$) of the cases. The 38.7% ($n = 12$) of the professionals presented job exhaustion, either due to emotional exhaustion, depersonalization, or low personal fulfillment. Finally, 64.5% ($n = 20$) and 74.2% ($n = 23$) considered that their mental or physical health has deteriorated due to working conditions given the current SARS-CoV-2 pandemic.

Conclusion: A considerable percentage of professionals presented job exhaustion. Some psychosocial and working conditions are highlighted (insufficient staff, exhausting workday, lack of collaboration, loss of information) associated with the presence of burnout. There is deterioration in the physical and mental health of professionals due to the SARS-CoV-2 pandemic.

© 2022 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

El síndrome de agotamiento profesional o *burnout* fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral por su capacidad para afectar la calidad de vida y salud mental de los trabajadores¹. Esta se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, entendido como sensaciones de sobre-esfuerzo físico y emocional, la despersonalización, por la existencia de actitudes negativas de insensibilidad y respuestas cínicas, y la disminución del desempeño personal, visto desde la tendencia a subvalorar el propio trabajo o contener sentimientos de falta competencia y éxito².

El *burnout* se presenta especialmente en aquellas profesiones donde se busca ofrecer un servicio o ayuda a un tercero³. Frente a ello, los profesionales que desempeñan labores en un contexto clínico pueden resultar vulnerables a mostrar síntomas de *burnout*. Se estima que un 20,7% presentan agotamiento emocional, un 3,4% despersonalización y un 62,1% baja realización personal. En España, entre 10 y 20% sufre desgaste profesional⁴. En Brasil, la prevalencia de *burnout* en profesionales de atención primaria oscila entre el 25 y 70%⁵. Como consecuencia de este síndrome, se ha referido aumento de tasas de absentismo laboral, incremento en el deseo de abandonar la organización y la profesión, así como distorsiones psiquiátricas y sexuales⁵.

Estudios previos han referido como factores de riesgo para el síndrome de agotamiento laboral, las altas demandas del sitio de trabajo, el escaso control sobre los resultados

de la actividad laboral, una menor edad del profesional, el sexo femenino, el estado civil, el tiempo de experiencia en el trabajo, la privación del sueño, así como contratos laborales temporales y toma de decisiones éticas⁶, siendo el exceso de trabajo, el ambiente físico de las instituciones y la falta de incentivos económicos generadores de estrés constante tanto por las exigencias intelectuales y físicas como actitudinales y emocionales³.

El estrés ha sido referido como un componente del *burnout* que puede clasificarse como estrés físico (horas de trabajo consecutivas sin descanso), psicológico (exposición a pacientes graves, muertes frecuentes, duelos de familiares) o sociológico (alcanzar las expectativas de los superiores, lograr una posición en el trabajo, tener un estatus personal). En fisioterapeutas se han relacionado determinantes tales como la relación familiar del profesional, las relaciones con sus compañeros de trabajo, la situación financiera y el insuficiente tiempo libre para actividades de ocio y recreación, manifestándose el *burnout* como despersonalización, principalmente entre hombres y agotamiento emocional entre mujeres⁶.

En Colombia, son escasos los estudios que analizan el agotamiento laboral y los factores que a nivel psicosocial, laboral o demográfico resultan asociados en profesionales de salud, y principalmente en disciplinas como fisioterapia y terapia respiratoria. El conocimiento sobre este fenómeno podría permitir a las instituciones prestadoras de servicios de salud implementar estrategias dirigidas a identificar oportunamente signos de agotamiento en sus profesionales e implementar intervenciones para mitigar las causas y

efectos sobre la salud física y mental de los mismos, de manera que se alcance un ambiente óptimo para el desempeño profesional que repercutiría en una mayor calidad de la atención a los pacientes. El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación de los factores psicosociales y laborales frente a la presencia de agotamiento laboral en fisioterapeutas y terapeutas respiratorios de un hospital de alta complejidad de Bogotá, Colombia.

Materiales y métodos

Diseño

Estudio observacional de corte transversal analítico.

Área y población de estudio

El área de estudio corresponde a una institución privada de cuarto nivel de complejidad, certificada y acreditada como hospital universitario en la ciudad de Bogotá. El hospital cuenta con más de 260 camas de capacidad instalada, que presta servicios a través de unidades de cuidados intensivos e intermedios, quirófanos, hospitalización y consulta externa para población neonatal, pediátrica y adulta. La población de estudio incluyó a la totalidad de profesionales del servicio de fisioterapia y terapia respiratoria con actividades clínicas directamente relacionadas a la atención de pacientes ya sea por consulta externa, hospitalización, urgencias o unidad de cuidados intensivos. Se excluyeron los profesionales que no estuvieron dispuestos a dar su consentimiento informado.

Variables de estudio

Se consideraron como variables demográficas el sexo (hombre o mujer), la edad (número de años) y el estado civil (casado, soltero, unión libre, viudo, divorciado). Dentro de las condiciones laborales se tuvieron en cuenta: cargo (fisioterapeuta, terapeuta respiratorio), posgrado (sí o no), tiempo de trabajo mensual (número de horas), turnos mensuales (número de turnos), ingresos económicos en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) (hasta dos SMMLV, entre dos y tres SMMLV, entre tres y cuatro SMMLV, más de cuatro SMMLV), estrato socioeconómico, siendo los estratos 1 -bajo bajo-, estrato 2 -bajo-, estrato 3 -medio bajo- los que albergan a los usuarios con menores recursos, mientras que los estratos 4 -medio-, estrato 5 -medio alto-, y estrato 6 -alto-, los usuarios con mayores recursos (menor o igual a estrato 3, mayor a estrato 3), tiempo de trabajo en la institución (número de meses), pacientes atendidos por turno (número de pacientes), tipo de contrato (término fijo, término indefinido, prestación de servicios), secuencia del turno (mañana, tarde, noche), y realiza más de una secuencia en el hospital (sí o no).

Para la medición de los factores psicosociales se consideraron algunos de los ítems confiables y con poder discriminación tomados del Cuestionario de Seguridad de los Pacientes, que evalúa elementos del entorno y cultura organizacional a través de las dimensiones de intercambio de información, trabajo en equipo, presión asistencial y

ritmo de trabajo, formación y comunicación entre personal, entre otros^{7,8}. Para el presente estudio se consideraron las siguientes variables: apoyo mutuo, suficiencia de personal para afrontar la carga laboral, trabajo en equipo, trato con respeto, percepción de jornada agotadora, ayuda entre compañeros, ritmo de trabajo y seguridad del paciente, superior toma en cuenta sugerencias del personal, gerencia facilita clima laboral adecuado, pérdida de información entre servicios o entre cambios de turno, problemas de atención por cambios de turno, y registro de órdenes sobre la atención en documento clínico. Las anteriores variables se respondieron a través de una escala tipo Likert de cuatro categorías (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo)^{7,8}.

Frente al agotamiento laboral se tuvieron en cuenta los ítems de cansancio emocional (nueve ítems), despersonalización (cinco ítems) y realización personal (ocho ítems), tomados del instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS) para profesionales de la salud, demostrando tener una adecuada validez de constructo y consistencia interna ($\alpha = 0,52$)⁹. Asimismo, se recolectaron datos sobre la percepción del impacto de las condiciones laborales por la actual pandemia por SARS-CoV-2 en la salud física y mental de los profesionales.

Instrumento de recolección de información

Se diseñó un cuestionario virtual mediante el aplicativo Microsoft Forms. Una primera versión del cuestionario virtual fue sometida a una prueba piloto para evaluar el ritmo, la comprensión de las preguntas y opciones de respuesta, la duración de la encuesta, la estructura y problemas de su aplicación. Este piloto se desarrolló con docentes del programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana, con experiencia clínica reciente. Posteriormente, se ajustó el instrumento con base en los resultados de la prueba piloto. El cuestionario final está dividido en las siguientes secciones: a) aspectos demográficos (tres ítems), b) aspectos psicosociales y laborales (37 ítems) y c) percepción de agotamiento laboral (MBI-HSS) (22 ítems). La recolección de los datos se llevó a cabo entre octubre y noviembre del 2020.

Técnicas de procesamiento y análisis de los datos

Para las variables psicosociales se realizó una recategorización de las opciones de respuesta: sí (totalmente de acuerdo y de acuerdo) y no (totalmente en desacuerdo y en desacuerdo). Frente al procesamiento de los datos obtenidos del MBI-HSS, se consideraron los siguientes puntos de corte de acuerdo con cada componente del burnout: cansancio emocional (bajo = 0-18; medio = 19-26; alto = 27-54); despersonalización (bajo = 0-5; medio = 6-9; alto = 10-30); realización personal (bajo = 0-33; medio = 34-39; alto = 40-56). Se definió la presencia de burnout con la afectación de al menos una subescala (niveles altos de cansancio emocional o despersonalización, o bajos niveles de realización personal)¹⁰.

Se llevó a cabo un proceso de depuración de la base de datos con el fin de evidenciar y corregir inconsistencias frente al diligenciamiento del instrumento. En el caso de

preguntas sin responder, fue necesario contactar telefónicamente a los profesionales.

Se llevaron a cabo análisis univariados para describir las variables dependientes (*burnout*) e independientes (condiciones laborales, psicosociales). Las variables cualitativas se describieron a través de frecuencias absolutas y relativas. Las variables cuantitativas se describieron a través de medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar, mínimo y máximo), acorde con la distribución de sus datos evaluados por medio de la prueba Shapiro-Wilk. Se realizaron análisis bivariados utilizando como pruebas de hipótesis χ^2 o pruebas exactas de Fisher. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25.

Consideraciones éticas

Este estudio recibió el aval ético por parte de la Corporación Universitaria Iberoamericana el 11 de marzo de 2020 y de la institución hospitalaria participante mediante el acta número 115 del 17 de septiembre de 2020. Se solicitó el consentimiento informado que contenía información respecto al objetivo del estudio, así como sus beneficios y riesgos para los participantes, refiriendo el carácter de participación voluntaria libre de pago y con libertad para detener la encuesta cuando quisiera. El estudio garantizó el anonimato y confidencialidad de los datos personales, dando cumplimiento a los principios éticos de la investigación en seres humanos.

Resultados

Del total de fisioterapeutas y terapeutas respiratorios disponibles en la institución ($n = 41$), se obtuvo una respuesta del 75% de estos profesionales ($n = 31$). Para las personas que respondieron, la edad fue de $36 \pm 8,7$ años, la distribución por sexo fue en el 93,5% ($n = 29$) para las mujeres. Frente a la realización de estudios de posgrado (especialización, maestría, doctorado), el 74,2% ($n = 23$) no ha realizado ningún estudio posgradual. En el 67,7% ($n = 21$), los ingresos económicos promedio de los profesionales oscilan entre dos y tres SMMLV. Con relación al estrato socioeconómico, el 87,1% ($n = 27$) habitan en viviendas en un estrato menor o igual al tres. Respecto al vínculo laboral de los profesionales, el tipo de contrato de la mayoría es a término fijo (96,8%; $n = 30$). El 38,7% ($n = 12$) refirió atender más de 15 pacientes por turno (tabla 1).

Con respecto a los resultados de la escala de burnout (MBI-HSS), el 39% ($n = 12$) de los profesionales percibió un alto cansancio emocional, el 16% ($n = 5$) un alto nivel de despersonalización y el 3% ($n = 1$) un bajo nivel de realización personal (fig. 1). A nivel general, el 38,7% ($n = 12$) de los profesionales presentan burnout. Un elevado porcentaje de los profesionales vieron deteriorada su salud física (64,5%, $n = 20$) y mental (74,2%, $n = 23$) por la actual pandemia por Covid-19, encontrando una peor percepción de deterioro en ambos componentes de la salud entre quienes presentan burnout con relación a los que no presentan agotamiento laboral ($p < 0,05$) (tabla 2).

Con relación a las condiciones psicosociales, la mayoría de los profesionales refieren estar de acuerdo y totalmente de acuerdo frente a que *el personal se apoya mutuamente*

(80,6%; $n = 25$). Sin embargo, los profesionales reconocen que no hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo (58,1%; $n = 18$). El 93,6% ($n = 29$) describieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en alusión a que existe respeto en el servicio. Al ítem a veces no se puede proporcionar la mejor atención al paciente porque la jornada es agotadora, el 51,6% ($n = 16$) refirió estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, encontrando una peor percepción entre las personas que tienen burnout ($p < 0,05$). Por otra parte, el 90% ($n = 26$) considera estar de acuerdo y totalmente de acuerdo sobre si el superior/jefe tiene en cuenta seriamente las sugerencias que le hace el personal para mejorar la seguridad del paciente, no obstante, una menor percepción se presentó entre quienes tienen burnout frente a los que no ($p = 0,033$) (tabla 3).

Con respecto a la percepción: cuando se reciben verbalmente órdenes sobre tratamientos, cuidados o procedimientos a realizar, el personal que las recibe las anota en el documento clínico que corresponde, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas, las personas que tienen burnout perciben en mayor medida que esta condición no se da (50%; $n = 5$), comparado con los que no presentan agotamiento laboral (5,3%; $n = 1$) (tabla 3).

Discusión

Este estudio aporta información útil respecto a las condiciones que impactan la presencia de *burnout* en disciplinas poco estudiadas como lo son fisioterapia y terapia respiratoria^{11,12}, lo que permite la visibilidad del fenómeno en estudio en estas profesiones para el contexto colombiano y que podría favorecer en la adopción de estrategias de mejora por parte de instituciones hospitalarias frente a la gestión del recurso humano, el ambiente laboral u otros aspectos del orden psicosocial.

Con base en nuestros resultados, algunos de los factores psicosociales y laborales que más atrajeron la atención fueron la percepción de carencia de personal, jornadas agotadoras, falta de colaboración como equipo y pérdida y/o intercambio problemático de información clínica, que podría verse reflejado en condiciones laborales y de ambiente que dificultan el desempeño de las funciones asistenciales en los profesionales. Acorde con previos estudios, la sobrecarga laboral es una de las dimensiones que gana terreno en la preocupación de aquellos que estudian las condiciones de trabajo y la efectividad del desempeño laboral, relacionando al exceso de actividades con impactos negativos frente al rendimiento en las funciones de los trabajadores en cualquier empresa^{11,13}.

Adicionalmente, se evidencia cómo las exigencias psicosociales y laborales relacionadas con la complejidad de las actividades realizadas requieren de un adecuado soporte y comunicación interprofesional, para que al momento que el profesional lo requiera, el soporte le brinde la posibilidad de disminuir la sobrecarga emocional, el riesgo de afectación de su calidad de vida y/o del trabajo ejecutado^{11,13}, o asimismo, que pueda repercutir en la reducción de la probabilidad de deserción laboral, estrés y depresión en el personal clínico^{12,14,15}.

Frente a las consecuencias que ha traído consigo la pandemia por COVID-19, de este estudio se denotan las

Tabla 1 Características sociodemográficas y laborales de los profesionales de fisioterapia y terapia respiratoria de un hospital de alta complejidad de Bogotá, Colombia (n = 31)

Variable	Valor
<i>Edad (media en años±DE)</i>	36±8,7
<i>Sexo, n (%)</i>	
Hombre	2 (6,5)
Mujer	29 (93,5)
<i>Estado civil, n (%)</i>	
Casado	10 (32,3)
Soltero	15 (48,4)
Unión libre	6 (19,4)
<i>Cargo, n (%)</i>	
Fisioterapia	6 (19,4)
Terapia respiratoria	25 (80,6)
Tiempo de trabajo en la institución (mediana en meses, mínimo – máximo)	38, 2 -144
<i>Estrato socioeconómico, n (%)</i>	
Menor o igual a estrato 3	27 (87,1)
Mayor a estrato 3	4 (12,9)
<i>Posgrado, n (%)</i>	
Si	8 (25,8)
No	23 (74,2)
<i>Ingresos económicos, n (%)</i>	
Hasta 2 SMMLV	7 (22,6)
Entre 2 y 3 SMMLV	21 (67,7)
Entre 3 y 4 SMMLV	2 (6,5)
Más de 4 SMMLV	1 (3,2)
<i>Tipo de contrato, n (%)</i>	
Término fijo	30 (96,8)
Prestación de servicios	1 (3,2)
Tiempo de trabajo mensual (mediana en horas, mínimo – máximo)	180, 120 – 196
Turnos mensuales (mediana en turnos, mínimo – máximo)	24, 5 – 38
<i>Secuencia del turno, n (%)</i>	
Mañana	13 (41,9)
Tarde	8 (25,8)
Noche	10 (32,3)
<i>Realiza más de una secuencia en el hospital</i>	
No	30 (96,8)
Si	1 (3,2)
<i>Número de pacientes atendidos por turno</i>	
Menos de 6 pacientes	1 (3,2)
De 6 a 10 pacientes	9 (29,0)
De 11 a 15 pacientes	9 (29,0)
Más de 15 pacientes	12 (38,7)

SMMLV: Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes; DE: desviación estándar.

percepciones de empeoramiento en la salud mental y física en los profesionales de fisioterapia y terapia respiratoria. Lo anterior concuerda con la revisión sistemática efectuada por Vindegaard et al.¹⁶ sobre desenlaces en la salud mental producto del COVID-19. Para el caso de los profesionales de salud, se evidencia una mayor sintomatología depresiva, ansiedad, peor calidad del sueño, así como mayores niveles de síntomas de desórdenes compulsivos obsesivos al momento de compararse con la normalidad o

con personal no asistencial, denotándose entre los principales factores para estos desenlaces, laborar en la atención clínica de primera línea con participación directa en el diagnóstico, tratamiento, cuidado y/o rehabilitación de pacientes infectados por SARS-CoV-2¹⁶, como corresponden a las competencias profesionales de la fisioterapia y terapia respiratoria.

Frente a los componentes del agotamiento laboral medido con la herramienta MBI-HSS, la despersonalización

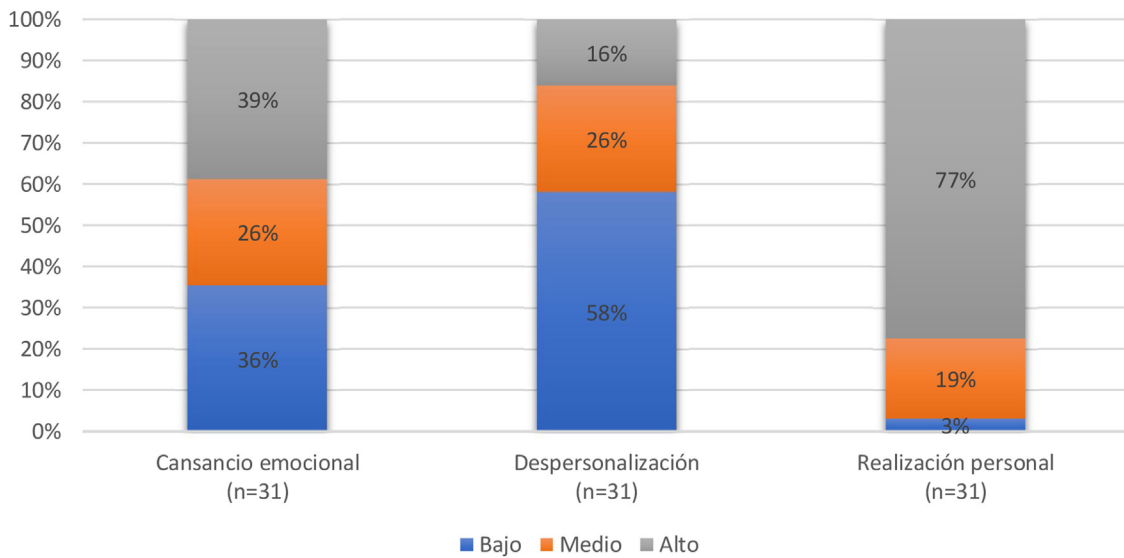


Figura 1 Resultados de las subescalas del MBI-HSS.

Tabla 2 Percepción de salud física y mental frente a la pandemia por SARS-CoV-2 (n = 31)

Ítem	Presencia de <i>burnout</i>			Valor p
	Tiene n (%)	No tiene n (%)	Total n (%)	
<i>¿Considera que su salud mental se ha visto deteriorada por el impacto de las condiciones laborales por la actual pandemia?</i>				
Sí	12 (100,0) -	8 (42,1)	20 (64,5)	0,001*
No	12 (100,0)	11 (57,9)	11 (35,5)	
Total		19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>¿Considera que su salud física se ha visto deteriorada por el impacto de las condiciones laborales por la actual pandemia?</i>				
Sí	12 (100,0)	11 (57,9)	23 (74,2)	0,012*
No	-	8 (42,1)	8 (25,8)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	

* Resultado de prueba exacta de Fisher.

es uno de los parámetros más relevantes a evaluar. En el estudio realizado por De la Cruz, la despersonalización se caracteriza por el desarrollo de actitudes negativas hacia los pacientes¹⁷, lo que para este estudio se vio reflejado en un porcentaje considerable (42%) de profesionales que presentan niveles altos y medios de despersonalización, que sugiere cambios en aspectos actitudinales tales como deshumanización de la atención, insensibilidad, endurecimiento emocional o falta de importancia frente al desenlace clínico del paciente.

En el presente estudio, más de la mitad de los encuestados sufren niveles medios y altos de cansancio emocional, evaluado desde el MBI-HSS como cansancio y fatiga que se manifiesta física y psíquicamente como tensión para la atención de los pacientes, frustración frente al trabajo o percepción de encontrarse al límite de las posibilidades. Este hallazgo es similar al encontrado por Araujo et al. en fisioterapeutas brasileños en unidades de cuidados intensivos (UCI) (UCI adultos: 56%; UCI neonatal y pediátrica:

64,7%)¹⁸, puede estar relacionado con las altas demandas de trabajo, así como la falta de preparación del profesional para solventar las altas cargas que a nivel emocional e interpersonal exige el contexto clínico que, entre otros elementos, se caracteriza por exposiciones directas con enfermedad, muerte y duelo¹⁹.

Frente a la realización personal, Figueiredo et al. relacionan este componente como otro aspecto clave a evaluar frente al agotamiento laboral²⁰. La baja realización personal se asocia fundamentalmente con un alejamiento de la persona a actividades no laborales (familiares, sociales, recreativas) que implican reducción del estrés crónico²¹. Otros síntomas relacionados con la baja realización personal se caracterizan por problemas de autoestima, percepción de fracaso y decepción hacia la vida personal y profesional²². Contrario a otras dimensiones evaluadas del *burnout*, en el presente estudio, la realización personal fue de las mejores evaluadas al encontrarse alta en el 77% de los profesionales, lo cual contrasta con niveles más bajos (12 - 25%)

Tabla 3 Condiciones psicosociales y laborales asociadas a la presencia de *burnout* (n = 31)

Ítem	Presencia de burnout			Valor p
	Tiene n (%)	No tiene n (%)	Total n (%)	
<i>El personal se apoya mutuamente</i>				
Sí	10 (83,3)	16 (84,2)	26 (83,9)	1,000*
No	2 (16,7)	3 (15,8)	5 (16,1)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo</i>				
Sí	6 (50,0)	7 (36,8)	13 (41,9)	0,470
No	6 (50,0)	12 (63,2)	18 (58,1)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>Cuando tenemos mucho trabajo, colaboramos como equipo para terminarlo</i>				
Sí	8 (66,7)	14 (73,7)	22 (71,0)	0,704*
No	4 (33,3)	5 (26,3)	9 (29,0)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>En el servicio nos tratamos todos con respeto</i>				
Sí	10 (83,3)	19 (100,0)	2 (6,5)	0,142*
No	2 (16,7)	-	29 (93,5)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>A veces no se puede proporcionar la mejor atención al paciente porque la jornada es agotadora</i>				
Sí	10 (83,3)	5 (26,3)	15 (48,4)	0,002+
No	2 (16,7)	14 (73,7)	16 (51,6)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>Cuando alguien está sobrecargado de trabajo, suele encontrar ayuda en los compañeros</i>				
Sí	6 (60,0)	14 (77,8)	20 (71,4)	0,400*
No	4 (40,0)	4 (22,2)	8 (28,6)	
Total	10 (100,0)	18 (100,0)	28 (100,0)	
<i>Nunca se aumenta el ritmo de trabajo si eso implica sacrificar la seguridad del paciente</i>				
Sí	4 (33,3)	6 (31,6)	10 (32,3)	1,000*
No	8 (66,7)	13 (68,4)	21 (67,7)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>Mi superior/jefe tiene en cuenta seriamente las sugerencias que le hace el personal para mejorar la seguridad del paciente</i>				
Sí	7 (70,0)	19 (100,0)	26 (89,7)	0,033*
No	3 (30,0)	-	3 (10,3)	
Total	10 (100,0)	19 (100,0)	29 (100,0)	
<i>La gerencia o la dirección del hospital facilita un clima laboral adecuado para un buen ambiente de trabajo</i>				
Sí	7 (70,0)	18 (94,7)	25 (86,2)	0,105*
No	3 (30,0)	1 (5,3)	4 (13,8)	
Total	10 (100,0)	19 (100,0)	29 (100,0)	
<i>La información de los pacientes se pierde, en parte, cuando estos se transfieren desde una unidad/ servicio a otra</i>				
Sí	6 (50,0)	7 (36,8)	18 (58,1)	0,470+
No	6 (50,0)	12 (63,2)	13 (41,9)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>En los cambios de turno se pierde con frecuencia información importante sobre la atención que ha recibido el paciente</i>				
Sí	5 (50,0)	6 (31,6)	11 (37,9)	0,432*
No	5 (50,0)	13 (68,4)	18 (62,1)	
Total	10 (100,0)	19 (100,0)	29 (100,0)	
<i>Cuando tenemos mucho trabajo, colaboramos como equipo para poder terminarlo</i>				
Sí	8 (80,0)	18 (94,7)	26 (89,7)	0,267*
No	2 (20,0)	1 (5,3)	3 (10,3)	

Tabla 3 (continuación)

Ítem	Presencia de burnout			Valor p
	Tiene n (%)	No tiene n (%)	Total n (%)	
Total	10 (100,0)	19 (100,0)	29 (100,0)	
<i>El intercambio de información entre los diferentes servicios es habitualmente problemático</i>				
Sí	5 (41,7)	5 (26,3)	10 (32,3)	0,447*
No	7 (58,3)	14 (73,7)	21 (67,7)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>Surgen problemas en la atención de los pacientes como consecuencia de los cambios de turno</i>				
Sí	3 (25,0)	5 (26,3)	8 (25,8)	1,000*
No	9 (75,0)	14 (73,7)	23 (74,2)	
Total	12 (100,0)	19 (100,0)	31 (100,0)	
<i>Cuando se reciben verbalmente órdenes sobre tratamientos, cuidados o procedimientos a realizar, el personal que las recibe las anota en el documento clínico que corresponde</i>				
Sí	5 (50,0)	18 (94,7)	23 (79,3)	0,011*
No	5 (50,0)	1 (5,3)	6 (20,7)	
Total	10 (100,0)	19 (100,0)	29 (100,0)	

* Resultado de prueba exacta de Fisher. + Resultado de prueba χ^2 .

encontrados en otras investigaciones^{11,23} o con valores promedio de 26,25 puntos en la escala MBI ($\pm 9,56$) en fisioterapeutas polacos reportados durante la pandemia por COVID-19²⁴. Lo anterior sugiere que en nuestro caso si bien se da la existencia de elementos estresores en el ambiente laboral, la tendencia es que los fisioterapeutas y terapeutas respiratorios estén satisfechos con su profesión.

Se destaca como principal limitación de este estudio el número de los profesionales caracterizados, que impidió la realización de análisis multivariados y el control de posibles confusores frente al análisis de los factores asociados a la presencia de agotamiento laboral. Esta limitación fue producto del reducido número de fisioterapeutas y terapeutas respiratorios que laboraban en la institución, así como por el rechazo de algunos a participar en el estudio, al tiempo que la selección de la muestra no se produjo de manera aleatoria. Ante estas consideraciones, los resultados de la presente investigación no pretenden ser generalizables a otras instituciones hospitalarias, sin embargo, pueden tomarse como referente para el análisis del agotamiento laboral no solo para las profesiones en este estudio sino también para otras de la salud. Finalmente, es una limitación propia de los estudios transversales la dificultad para inferir causalidad entre las variables que surgieron asociadas estadísticamente en los análisis bivariados.

Conclusiones

En un hospital de alta complejidad se presenta un porcentaje considerable de fisioterapeutas y terapeutas respiratorios con agotamiento laboral. Como condiciones psicosociales y laborales asociadas a la presencia de burnout, se destacaron la falta de personal, la jornada agotadora, la falta de colaboración como equipo y la pérdida e intercambio problemático de información de los pacientes. Adicionalmente, las condiciones laborales por la pandemia

SARS-CoV-2, se reflejan en una alta percepción de deterioro de la salud física y mental de los profesionales, que se encuentran en constante tensión y riesgo debido a su actividad clínica.

Financiación

Esta investigación fue financiada por la Corporación Universitaria Iberoamericana por medio de su Fondo de Investigaciones, la Facultad de Ciencias de la Salud y el programa de fisioterapia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés frente a la investigación, la autoría o la publicación de este artículo.

Agradecimientos

Los autores ofrecen un especial agradecimiento a la Institución Hospital Infantil Universitario de San José por permitir la realización de este estudio con sus profesionales. De igual manera, agradecer a los fisioterapeutas y terapeutas respiratorios que generosamente compartieron sus percepciones y experiencias.

Bibliografía

- Organización Mundial de la Salud. La organización del trabajo y el estrés [Internet]. Francia. WHO. 2004;37 [consultado 10 Sep 2020]. Disponible en: https://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3sp.pdf?ua=1
- Faúndez VEO, Mena-Miranda L, Wilke CJ, Sepúlveda FM. Validez factorial del Maslach Burnout Inventory human services (MBI-HSS) en profesionales chilenos. Univ Psychol. 2014;13.

3. Gutiérrez-Lesmes OA, Loba-Rodríguez NJ, Martínez-Torres J. Prevalencia del Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería de la Orinoquia colombiana, 2016. *Univ y Salud*. 2018;20:37–43.
4. Gomero Cuadra R, Palomino Baldeón J, Ruiz Gutierrez F, Llap Yesán C. El Síndrome de Burnout en personal sanitario de los hospitales de la empresa minera de Southern Perú Copper Corporation: estudio Piloto. *Rev Medica Hered*. 2005;16:233–8.
5. Saborío Morales L, Hidalgo Murillo LF. Síndrome de Burnout. *Med Leg Costa Rica*. 2015;32:119–24.
6. Śliwiński Z, Starczyńska M, Kotela I, Kowalski T, Kryś-Noszczyk K, Lietz-Kijak D, et al. Life satisfaction and risk of burnout among men and women working as physiotherapists. *Int J Occup Med Environ Health*. 2014;27:400–12, <http://dx.doi.org/10.2478/s13382-014-0266-8>.
7. Ministerio de Sanidad y Consumo. Cuestionario Sobre Seguridad de los Pacientes. 2005:17 [consultado 11 Sep 2020]. Disponible en: <http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/CuestionarioSeguridadPacientes1.pdf>
8. Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad. Traducción, validación y adaptación del cuestionario MOSPS para medir la cultura de seguridad del paciente en Atención Primaria. 2011;103.
9. Córdoba L, Tamayo JA, González MA, Martínez MI, Rosales A, Barbato SH. Adaptation and validation of the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey in Cali Colombia. *Colomb Med*. 2011;42:286–93.
10. Castañeda Aguilera E, de Alba García JE. Prevalencia del síndrome de agotamiento profesional (burnout) en médicos familiares mexicanos: análisis de factores de riesgo. *Rev Colomb Psiquiatr*. 2010;39:67–84, [http://dx.doi.org/10.1016/S0034-7450\(14\)60237-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0034-7450(14)60237-7).
11. Castro Sánchez AM, Rodríguez Claro ML, Moreno Lorenzo C, Vicente Martín C, Arroyo Morales M, Fernández Fernández MJ. Prevalencia del Síndrome de Burnout en Fisioterapia. *Fisioterapia* [Internet]. 2006;28:17–22, [http://dx.doi.org/10.1016/S0211-5638\(06\)74017-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0211-5638(06)74017-2).
12. García-Sanz E, Jiménez-Rejano JJ, Pérez-Cabezas V, Chillón-Martínez R, de la Casa Almeida M, Rebollo-Salas M. Calidad de vida profesional de los fisioterapeutas en el ámbito hospitalario público de Sevilla. *Fisioterapia*. 2018;40:65–72.
13. Cerón López EM. Síndrome de burnout en enfermeros de hospitales públicos y privados en Guayaquil, Ecuador. *Revista Medicina e Investigación Clínica Guayaquil*. 2020;1:33–40, <http://dx.doi.org/10.51597/rmicg.v1i1.55>.
14. Agudelo Cardona CA, Castaño Castrillón JJ, Arango CA, Durango Rodríguez LA, Muñoz Gallego V, Ospina González A, et al. Prevalencia y factores psicosociales asociados al Síndrome de Burnout en médicos que laboran en instituciones de las ciudades de Manizales y la Virginia (Colombia) 2011. *Arch Med*. 2011;11:91–100.
15. Peraza de Aparicio CX. Salud laboral frente a la pandemia del COVID-19 en Ecuador. *MediSur*. 2020;18:507–11.
16. Vindegaard N, Benros ME. COVID-19 pandemic and mental health consequences: Systematic review of the current evidence. *Brain Behav Immun*. 2020;89:531–42, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.048>.
17. De La Cruz SP, Abellan MV. Professional burnout, stress and job satisfaction of nursing staff at a university hospital. *Rev Lat Am Enfermagem*. 2015;23:543–52.
18. Araújo R, Araújo B, Morais CCA, Campos SL, Andrade ADde, Brandão DC. Síndrome de Burnout: realidade dos fisioterapeutas intensivistas? *Fisioter e Pesqui*. 2018;25:388–94.
19. Ortega Ruiz C, López Ríos F. El burnout o síndrome de estar quemado en los profesionales sanitarios: revisión y perspectivas. *Int J Clin Heal Psychol*. 2004;4:137–60.
20. Figueiredo-Ferraz H, Grau-Alberola E, Gil-Monte PR, García-Jueas JA. Burnout and job satisfaction among nursing professionals. *Psicothema*. 2012;24:271–6.
21. Rodríguez Paipilla MG, Rodríguez Gómez R, Riveros Gutiérrez AE, Rodríguez D'luyz ML, Pinzón Salamanca JY. Síndrome de burnout y factores asociados en personal de salud en tres instituciones de Bogotá en diciembre de 2010. Repositorio Institucional Universidad del Rosario. 2011 [consultado 15 Sep 2020]. Disponible en: <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2389/RodriguezPaipilla-MagdaGinnette-2011.pdf>
22. Blanca-Gutiérrez J, Arias-Herrera A. Síndrome de burnout en personal de enfermería: asociación con estresores del entorno hospitalario, Andalucía España. *Enfermería Univ*. 2018;15.
23. Carmona-Barrientos I, Gala-León FJ, Lupiani-Giménez M, Cruz-Barrientos A, Lucena-Anton D, Moral-Munoz JA. Occupational stress and burnout among physiotherapists: a cross-sectional survey in Cadiz (Spain). *Hum Resour Health*. 2020;18:1–10, <http://dx.doi.org/10.1186/s12960-020-00537-0>.
24. Pniak B, Leszczak J, Adamczyk M, Rusek W, Matosz P, Guzik A. Occupational burnout among active physiotherapists working in clinical hospitals during the COVID-19 pandemic in south-eastern Poland. *Work*. 2021;68:285–95.